

Salute Mentale — Panoramica completa

Semestre 02 · 13 lezioni

Da Ippocrate ai neuroni specchio, dalla follia incatenata alla diagnosi DSM-5-TR: questo corso ha costruito uno sguardo integrato sulla mente umana. Il filo conduttore è la relazione — con sé stessi, con l'altro, con il proprio corpo. Il disagio non è mai un'etichetta: è un incontro da capire.

Mappa dei temi

#	Lezione	Tema centrale
01	Intro al modulo	Salute, benessere, normalità — i fondamentali concettuali
02	Storia della follia	Evoluzione dei paradigmi psichiatrici dall'antichità al '900
03	Le empatie	Empatia: modelli, sviluppo, bias e limiti professionali
04	Dalla paura alle difese	Paura, ansia, angoscia e meccanismi di difesa dell'Io
05	Dispercepire il mondo	Semiologia: comportamento, stato mentale, percezione, psicofarmaci
06	Sindromi affettive e ansiose	Depressioni, disturbi bipolari, disturbi d'ansia
07	Le nevrosi	DOC, isteria, struttura nevrotica, egodistonia
08		

#	Lezione	Tema centrale
	I disturbi di personalità	Temperamento, carattere, cluster A/B/C, organizzazione Kernberg
09	Le psicosi	Schizofrenia, demenze, psicosi organiche e funzionali
10	Il corpo sessuato	Sessualità, identità di genere, disforia, parafilie
11	Il corpo deformato	Disturbi alimentari: anoressia, bulimia, BED, ortoressia
12	Il corpo alessitimico	Alessitimia, regolazione affettiva, intelligenza emotiva
13	Il corpo violato	Rabbia, aggressività, violenza, disimpegno morale

Fondamenti concettuali

- **Salute** → funzionalità e potenzialità · **Benessere** → vissuto soggettivo (Ryff: 6 dimensioni) · **Normalità** → statistica / di valore / individuale · (Lez. 01)
- **Disease / Illness / Sickness** (Hoffman) → biomedica · soggettiva · sociale · possono non coincidere · lo stigma peggiora il decorso · (Lez. 01)
- **Continuum** → benessere → disagio → malessere → disturbo → malattia mentale (Lez. 01)
- **Agentività vs. identificazione** → agire sulla condizione vs. essere la condizione · (Lez. 01)
 - **To cure** (guarigione) ≠ **To care** (cura) → la cura è praticabile anche senza guarigione
- **Linguaggio** → "È schizofrenico" vs. "ha una schizofrenia" → diagnosi ≠ identità · (Lez. 01, 02)
- **Patologia vs. normalità** → 3 criteri: durata · intensità · compromissione · (Lez. 07)

I due paradigmi della follia

- **Gehirnpsychiatrie** → follia = malattia organica del cervello (Griesinger) · (Lez. 02)
- **Geistespsychiatrie** → follia = prodotto di passioni / traumi / vita (Pinel) · (Lez. 02)
- **Comprensibilità (Jaspers)** → follia passionale comprensibile · follia organica incomprensibile · (Lez. 02)
- **Alienazione** → essere "altrove", fuori dal proprio mondo · identità · spazio · tempo · (Lez. 02)
- **Avere vs. essere la malattia** → non-identificazione vs. identificazione identitaria → paradigmi di cura diversi · (Lez. 01, 02)

Evoluzione storica della psichiatria

- **Ippocrate (~460 a.C.)** → emancipazione dalla religione · teoria degli umori · (Lez. 02)
 - **Pinel (1793)** → Bicêtre · **guaribilità** · **patoplastica** · **parzialità della follia** · **trattamento morale** · (Lez. 02)
 - Conoscere la storia del paziente → preconditione della cura
 - **Kraepelin** → nosologia · endogene / esogene · psicosi maniaco-depressiva vs. demenza precoce · (Lez. 02)
 - **Bleuler (1911)** → schizofrenia · sintomi primari / secondari · recupera la patoplastica · (Lez. 02, 09)
 - **Charcot** → **Freud** → dall'ipnosi alla dinamica inconscia · (Lez. 07)
 - **DSM-III in poi** → abbandono del termine "nevrosi", frammentazione in diagnosi specifiche · (Lez. 07)
 - **Cargnello** → ambiguità irriducibile della psichiatria: "essere con qualcuno" vs. "avere qualcosa di fronte" · (Lez. 01, 02)
-

Empatia e relazione di cura

- **Einfühlung** → "sentire dentro" (Lipps, 1905) · base: neuroni specchio / simulazione incarnata (Gallese, 2003) · (Lez. 03)
 - **Critica del "mettersi nei panni"** → stare accanto, non al posto dell'altro (Ricoeur, Pezzoli) · (Lez. 03)
 - **Modello Feshbach (1987)** → 3 componenti: assunzione di prospettiva · decodifica emotiva · risonanza affettiva · TOM (Wellman) · preconditione: distinzione sé/altro · (Lez. 03)
 - **Modello Hoffman (2000)** → empatie al plurale · evolutive · motivazionali · 5 stadi dallo 0 ai 12 mesi all'adolescenza · (Lez. 03)
 - Ogni stadio evolutivo richiede la preconditione cognitiva corrispondente
 - **Empatia / simpatia / compassione** → *feeling with* vs. *feeling for* + motivazione proattiva (Singer & Klimecki) · (Lez. 03)
 - **6 bias empatici (Pezzoli)** → (Lez. 03)
 - Non empatizziamo ugualmente · giudizio morale / estetico inibisce · chi inganna o invidiamo · insensibilità numerica · non rende più buoni · faticosa e dolorosa → **burnout**
 - **Empatia egocentrica** → aiutare con ciò che consola sé ≠ empatia matura · (Lez. 03, 04)
-

Emozioni, paura, ansia e umore

- **Emozione** (Galimberti) → reattiva, acuta, con oggetto · **Umore** (Delay) → disposizione di fondo · (Lez. 06)
- **Emozioni di base** → Ekman & Friesen (6) · Plutchik: 8 + fiore (intensità, attenuazione, combinazioni) · (Lez. 04, 06)
- **Filiera della paura** → minaccia → valutazione protocognitiva → paura → fuga / attacco / mimetismo · (Lez. 04)
- **Paura vs. ansia** → oggetto concreto + breve (amigdala) vs. futuro ipotetico + prolungata (BNST) · (Lez. 04, 06)
 - **Freezing** → intensità supera soglia di arousal: paralisi · (Lez. 04)
- **Ansia normale vs. patologica** (Biondi) · **ansia di stato vs. di tratto** (Sims & Snaith) · (Lez. 04, 06)

- **Rimuginio ansioso vs. ruminazione depressiva** → futuro vs. passato · alimenta ansia vs. prolunga depressione · (Lez. 06)
 - **Fonti di angoscia (Freud, 1930)** → corpo · natura · **relazioni** (la più importante; porcospini di Schopenhauer) · (Lez. 04)
-

Meccanismi di difesa e struttura della personalità

Ponte tra Lez. 04 (classificazione), Lez. 07 (nevrosi), Lez. 08 (disturbi di personalità), Lez. 09 (psicosi).

- **MDD** → risposta automatica, inconscia, dell'Io contro l'angoscia (≠ coping cosciente) · (Lez. 04)
 - **3 criteri Anna Freud** → age adequateness · intensity · balance · (Lez. 04)
 - MDD primitivi in un adulto → segnale di alta angoscia del soggetto
 - **Primitivi** → ritiro · diniego · proiezione · introiezione · identificazione proiettiva · scissione · idealizzazione · svalutazione · controllo onnipotente · (Lez. 04)
 - **Maturi / secondari** → rimozione · dissociazione · formazione reattiva · spostamento · capovolgimento · isolamento affetti · intellettualizzazione · razionalizzazione · compartimentalizzazione · **umorismo** (il più maturo) · (Lez. 04)
 - **Scala di Perrotta (adatt. Pezzoli)** → 7 livelli da rottura con la realtà a difese mature · (Lez. 04)
 - **Angoscia specifica per area clinica** → (Lez. 04, 07, 08, 09)
 - Nevrosi → angoscia di **castrazione** (limite, prestazione)
 - Borderline → angoscia di **abbandono**
 - Psicosi → angoscia di **frammentazione** (identità, unità del sé)
 - **Organizzazione di personalità (Kernberg)** → struttura nevrotica / borderline / psicotica: identità · difese · esame di realtà · (Lez. 08)
 - **Struttura nevrotica (Bergeret)** → Super-Io dominante · conflitto edipico · difesa = rimozione · relazione genitale · diagnosi solo da adulti · (Lez. 07)
-

Semiologia: come si guarda il paziente

- **Segni vs. sintomi** → oggettivi (curante) vs. soggettivi (paziente) · (Lez. 05)
 - **Semiologia del comportamento** → apparenza (ipertimia, amimia, mimica discordante) · discorso · condotte istintuali · passaggi all'atto · funzioni psicomotorie (catatonia, tic, stereotipie) · (Lez. 05)
 - **Semiologia dello stato mentale** → (Lez. 05)
 - **Coscienza** → quantitative (lucidità → coma) / qualitative (delirium, mania à potu, oniroide, crepuscolare, fenomeni dissociativi)
 - **Orientamento** → tempo (labile, bassa gravità) · spazio (media) · persona (massima gravità se persa)
 - **Memoria** → sensoriale · breve termine · di lavoro · lungo termine (implicita + esplicita) · disturbi quantitativi (amnesie, ipo/ipermnesia) e qualitativi (confabulazioni, déjà vu)
 - **Attenzione** → selettiva · divisa · sostenuta (sensibile all'invecchiamento)
 - **Percezione** → sensazione (dato grezzo) vs. percezione (rielaborazione soggettiva) · illusione vs. allucinazione · agnosie, prosopagnosia, anosognosia
 - **Psicofarmacologia** → antipsicotici · antidepressivi · ansiolitici · stabilizzatori — la terapia è sempre integrata, il farmaco è una parte · ⚠ non dedurre la diagnosi dalla terapia · (Lez. 05)
-

Quadri clinici maggiori

Sindromi affettive (Lez. 06)

- **Nucleo depressivo (Klein)** → umore depresso · rallentamento psicomotorio e psichico · anedonia · apatia · alfa privativo
- **Classificazione Lalli (2002)** → primarie (carattere depressivo) vs. secondarie (organiche)
- **Tre gruppi clinici** → psicogene (vittima, reagisce all'ambiente) · endogene (colpevole, non reagisce · ⚠ stimolazione controproducente) · somatiche
- **DSM-5-TR** → disturbo depressivo maggiore (≥ 2 sett.) · persistente (≥ 2 anni) · depressione mascherata (≠ ipocondria)

- **Disturbi bipolari** → pendolo timico · bipolare I / II / ciclotimico · episodio maniacale: insonnia senza stanchezza, logorrea, fuga di idee, perdita contatto realtà · ⚠ no antidepressivi in solitaria (rischio mania) · terapia: stabilizzatori + litio (monitoraggio ematico) + psicoeducazione

Sindromi ansiose (Lez. 06)

- **Sintomi** → cognitivi, affettivi, fisiologici, comportamentali
- **Disturbi d'ansia DSM-5-TR** → DAG (rimuginio) · ansia sociale (vergogna) · panico · agorafobia · fobia specifica · ansia da separazione · mutismo selettivo
- **Attacco di panico** → picco in pochi minuti · ≥ 4 su 13 sintomi · accoglienza senza giudizio = strumento principale
- ⚠ DOC e PTSD → non nei disturbi d'ansia nel DSM-5-TR: hanno capitoli propri

Nevrosi (Lez. 07)

- **Definizione** → disturbo psichico senza causa organica · conflitto desiderio/ regola non risolto → sintomo · non è malattia
- **Sintomo egodistonico** → sa che è irrazionale, ne soffre, chiede aiuto · **egosintonico** → disturbi di personalità (Lez. 08)
- **Fenomenologia** → bassa autostima, colpa, vergogna · ansia dominante · sintomi somatici · **esame di realtà mantenuto** ($\neq$ psicosi)
- **DOC** → luogo del sintomo = pensiero · ossessioni (non desiderate, incongruenti, si resiste) · compulsioni (danno **sollievo** $\neq$ piacere) · evitamento
 - Difese nel DOC: rimozione · formazione reattiva · spostamento · isolamento · annullamento retroattivo
- **Nevrosi isterica** → luogo del sintomo = corpo · Charcot (ipnosi) → Freud (libere associazioni) · **conversione** del conflitto psichico sul piano somatico
 - Isterica di conversione (sintomi fisici) vs. isterica d'angoscia (fobia, spostamento)
- **Nel DSM-5-TR** → le nevrosi classiche si sono frammentate in disturbi d'ansia, DOC, traumatici, somatici, dissociativi

Disturbi di personalità (Lez. 08)

- **Personalità** → temperamento (biologico, congenito) + carattere (acquisito) = modalità stabili di pensare · sentire · comportarsi · relazionarsi
- **Tratto** (stabile, base dei disturbi di personalità) vs. **Stato** (temporaneo, base delle sindromi cliniche)
- **Da stile a disturbo** → tratti rigidi e pervasivi → sofferenza e/o compromissione · modello bio-psico-sociale (Paris): **diatesi** + stress = disturbo
- **Egosintonia** → tratti non percepiti come problematici → scarsa motivazione al trattamento
- **Cluster A** — strani ed eccentrici:
 - **Paranoide** → diffidenza pervasiva · difese: proiezione, identificazione proiettiva
 - **Schizoide** → distacco relazionale · difesa: ritiro (non vuole relazioni ≠ evitante)
 - **Schizotipico** → distorsioni cognitive/percettive · più vicino alla psicosi
- **Cluster B** — drammatici, emotivi, imprevedibili:
 - **Antisociale** → violazione diritti altrui · criterio: disturbo della condotta prima dei 15 anni
 - **Borderline (BPD)** → instabilità relazioni/identità/umore · scissione · angoscia di abbandono · suicidalità (80% ricoverati) · ~20% dei pazienti psichiatrici (Gunderson) · difese: scissione, identificazione proiettiva, dissociazione, acting out
 - **Narcisistico** → grandiosità, mancanza empatia emotiva · difese: idealizzazione, svalutazione
 - **Istrionico** → emotività eccessiva + ricerca attenzione · difese prevalentemente isteriche
- **Cluster C** — ansiosi e inibiti:
 - **Evitante** → vuole le relazioni ma le evita per paura (≠ schizoide) · tratto stabile (≠ ansia sociale)
 - **Dipendente** → bisogno pervasivo di accudimento
 - **DOCP** → ordine, perfezionismo, controllo · egosintonico · ⚠ no ossessioni/compulsioni vere (≠ DOC)

- **Organizzazione di personalità (Kernberg)** → nevrotica / borderline / psicotica: differiscono per identità, difese, esame di realtà
- **Trattamenti validati per BPD** → DBT (Linehan) · MBT · TFP (Kernberg)
- **Problema diagnostico** → DSM categoriale ↔ psicopatologia dimensionale · PDM-2 (Lingiardi & McWilliams) come alternativa

Psicosi (Lez. 09)

- **Definizione** → rapporto radicalmente alterato con la realtà · due destrutturazioni (Jervis): realtà esterna + identità interna
- **Psicosi organiche** → causa biologica nota · struttura io–qui–adesso crollata (sa né dove, né chi, né quando):
 - **Demenze** → Alzheimer, senile, acquisite (alcol, sifilide)
 - **Epilessia** → grande male (tonica → clonica → risolutiva) · piccolo male (assenza breve, senza convulsioni) · crisi parziali ⚠ può sembrare distrazione in classe/foyer
 - **Psicosi da sostanze** → sistema mesolimbico/dopamina · delirium tremens (astinenza alcolica) · Korsakov (amnesia anterograda cronica) · cannabis indoor (THC → rischio psicotico)
- **Psicosi funzionali** → multifattoriali · struttura io–qui–adesso intatta ma dissociata (sa ma non si sente)
- **Sintomatologia comune** → sintomi **positivi** (delirio + allucinazioni) · **negativi** (apatia, abulia, ritiro, appiattimento) · **disorganizzazione cognitiva**
- **Schizofrenia** (Bleuler, 1911) → *schizein* + *phren* · orchestra senza direttore · sindrome fondamentale:
 - **Dissociazione** intellettuale: disorganizzazione · impoverimento · concretismo · tangenzialità · deragliamento
 - **Dissociazione** affettiva: appiattimento · discordanza · ambivalenza
 - **Dissociazione** psicomotoria: ritiro · agitazione · crisi pantoclastica · manierismi
 - **Autismo schizofrenico** → perdita del contatto vitale con la realtà (sintomi negativi)
 - **Delirio** (Sims) → convinzione falsa, incrollabile, palese agli altri · contenuti: persecuzione, grandiosità, influenzamento

- **Depersonalizzazione / Derealizzazione** → sé come automa · mondo estraneo · tempo cristallizzato
 - **Allucinazioni** → prevalentemente uditive · ⚠️ voci perentorie con ordini pericolosi = massima vigilanza
 - **Tipo 1 vs. Tipo 2 (Crow, 1980)** → positivi/reversibili vs. negativi/cronici
 - **Decorso** → premorbo → prodromico → stato (~20 anni) → esiti · ⚠️ picco suicidalità nel **miglioramento**, non nello scompenso
 - **Fattori prognostici** → favorevoli: diagnosi precoce, intervento immediato, rete sociale, esordio tardivo · sfavorevoli: esordio precoce, familiarità, sintomi negativi dominanti
-

Il corpo nella sofferenza mentale

Corpo sessuato (Lez. 10)

- **Identità sessuale: 4 dimensioni** → sesso biologico (AFAB/AMAB/intersex ~1,7%) · identità di genere (cisgender, transgender, gender fluid, agender) · ruolo di genere · orientamento sessuale
- **Körper vs. Leib (Husserl)** → corpo-oggetto anatomico vs. corpo vissuto relazionale · nelle parafilie il corpo altrui è vissuto come *Körper*
- **Bisogno vs. desiderio** → passaggio evolutivo sano · bisogno non superato → compulsività → base delle parafilie
- **6 snodi di Lalli** → umanizzazione · dipendenza → autonomia · bisogno → desiderio · riconoscimento reciproco · fantasia · rapporto con l'altro · ogni snodo ha versione sana e versione patologica
- **DSM-5-TR** → disforia di genere (focus sulla sofferenza, non la condizione · transgender ≠ disforia) · disturbi parafilici (parafilia + danno/disagio)
- **8 disturbi parafilici** → voyeuristico · esibizionistico · pedofilico · feticistico · da travestitismo · masochismo sessuale · sadismo sessuale · frotteuristico

Corpo deformato — DCA (Lez. 11)

- **Cibo come primo mediatore relazionale** → prefigura le relazioni future · gusto = ippocampo + amigdala, mai neutro

- **DNA (DSM-5-TR)** → pica · ruminazione · evitante/restrittivo · anoressia nervosa · bulimia nervosa · BED (riconosciuto nel 2013)
- **Scissione mente-corpo (Selvini-Palazzoli, 1963)** → paura del corpo pubere, non del cibo · difficoltà separazione-individuazione (Mahler) · DCA come patologie narcisistiche
- **Falso sé compiacente (Bruch)** → "bambine perfette" con bisogni non riconosciuti · il sintomo = unico spazio di autonomia e controllo
- **DCA come disturbi etnici (Devereux)** → cultura = **fattore patoplastico** (Jaspers): plasma la forma, non è la causa · chi ha una vulnerabilità si ammala nella forma che la cultura indica
- **Eziologia multifattoriale** → predisponenti · precipitanti · cronicizzanti (distorsione immagine, spinta biologica, dinamiche familiari)
- **Ortoressia** (ossessione qualità, non DSM) · **Vigoressia** (Muscle Dysmorphia, Pope 1993: "anoressia inversa")

Corpo alessitimico (Lez. 12)

- **Alessitimia** (Sifneos, 1973) → mancanza di parole per le emozioni (*a + lexis* + *thymos*)
- **4 caratteristiche (Taylor)** → difficoltà a discriminare le emozioni · vocabolario emotivo limitato · fantasia deficitaria · stile cognitivo verso l'esterno
- ⚠ Le persone alessitimiche *provano* le emozioni — non riescono a nominarle
- **Tratto** (sviluppo infantile bloccato, stabile) vs. **Stato** (post-trauma, potenzialmente reversibile)
- **Costrutto transnosografico** → presente in disturbi dell'umore, d'ansia, alimentari, dipendenze, di personalità · **non nelle psicosi**
- **Trauma e alessitimia (Krystal)** → pericolo inevitabile → congelamento affettivo → sollievo paradossale
- **Intelligenza emotiva (Salovey & Mayer)** → 4 dimensioni: percezione/espressione · facilitazione del pensiero · comprensione/analisi · regolazione consapevole
- **Alessitimia e dipendenze** → la sostanza come stampella per regolare (o bloccare) le emozioni · attaccamento insicuro come fattore frequente

- **Strumenti** → TAS-20 · SAR · TSIA · ⚠ non fanno diagnosi, sono campanelli d'allarme

Corpo violato (Lez. 13)

- **Triade fondamentale** → **rabbia** (emozione, legittima) ≠ **aggressività** (forza orientata, benigna o maligna) ≠ **violenza** (declinazione maligna intenzionale) · non sono sinonimi
 - **Aggressività maligna a caldo** (reattiva, senso di colpa dopo · BPD) vs. **a freddo** (predatoria, pianificata, nessun senso di colpa · antisociale)
 - **Introdiretta** → verso sé (autolesionismo, dipendenze): evolutivamente più grave, viola il principio di autoconservazione
 - **Metafora del fiume** → argini rigidi = repressione · canalizzazione = trasforma la forza in risorsa · si costruisce nei periodi di calma
 - **Violenza domestica (OMS)** → ogni forma di violenza in ambito familiare/ coppia · ⚠ la psicologica è la prima ad apparire e la più invisibile
 - **Ciclo della violenza (Walker, 1979)** → accumulo → esplosione → ridimensionamento/colpa alla vittima → falsa riappacificazione → ricomincia
 - **Ruota del potere e del controllo (Progetto Duluth)** → motore: controllo · raggi: isolamento, violenza economica, intimidazioni, denigrazione, stalking
 - **Meccanismi di disimpegno morale (Bandura, 2017)** → sospendono selettivamente la moralità senza modificarla:
 - giustificazione morale · etichettamento eufemistico · confronto vantaggioso
 - spostamento / diffusione responsabilità · distorsione conseguenze
 - **deumanizzazione** · attribuzione di colpa alla vittima
 - ⚠ abitano tutti noi — anche gli operatori → vigilare nelle equipe
 - **Banalità del male (Arendt)** → il male si insinua nella quotidianità burocratica · solo il bene è radicale → vigilanza costante nelle relazioni d'aiuto
-

Autori e riferimenti principali

Chi	Contributo	Lezione
Boorse (1977)	7 criteri di salute/malattia	01
Ryff (1989)	6 dimensioni del benessere	01
Cargnello (1999)	Ambiguità della psichiatria; linguaggio e identità	01, 02
Ippocrate (~460 a.C.)	Teoria degli umori; emancipazione dalla religione	02
Pinel (1793)	Trattamento morale; 4 principi	02
Kraepelin	Nosologia; psicosi MD / demenza precoce	02
Bleuler (1911)	Schizofrenia; sintomi primari/secondari	02, 09
Jaspers	Comprensibilità vs. incomprendibilità; fattore patoplastico	02, 11
Lipps (1905) / Gallese (2003)	Einfühlung; simulazione incarnata	03
Feshbach (1987)	Modello multidimensionale dell'empatia	03
Hoffman (2000)	Empatie al plurale; modello evolutivo	03
Pezzoli (2026)	6 bias empatici; schema contesto × minaccia	03, 04
Freud / Anna Freud (1894–1936)	Difese; angoscia; disagio della civiltà	04
Klein	Posizione schizoide e depressiva; nucleo semiologico depressioni	04, 06
Bergeret	Struttura nevrotica/psicotica; scompenso	07
Charcot	Isteria; ipnosi; Salpêtrière	07

Chi	Contributo	Lezione
Abraham	Linea di divisione nevrotico/psicotico	07
Thomas, Chess & Birch (1968)	9 variabili temperamentali	08
Costa & McCrae (1988)	Big Five	08
Paris (1997)	Modello bio-psico-sociale dei disturbi di personalità	08
Kernberg	Organizzazione di personalità; TFP	08
Linehan	BPD "ustioni di terzo grado"; DBT	08
Gunderson & Links	BPD = ~20% dei pazienti psichiatrici	08
Lingiardi & McWilliams	PDM-2	08
Minkowski	Triade io–qui–adesso; psicosi organiche vs. funzionali	09
Jervis	Due destrutturazioni centrali nella psicosi	09
Crow (1980)	Tipo 1 (positivi) / Tipo 2 (negativi)	09
Husserl	Körper / Leib	10
Lalli	6 snodi dello sviluppo psicosessuale	10
Selvini-Palazzoli (1963)	Scissione mente-corpo nell'anoressia	11
Bruch (1978)	Falso sé compiacente; "La gabbia d'oro"	11
Devereux (1978)	Disturbi etnici / Culture-Bound Syndromes	11
Sifneos (1973)	Conia il termine "alessitimia"	12
Taylor (1997)	4 caratteristiche dell'alessitimia	12
Krystal		12

Chi	Contributo	Lezione
	Trauma e alessitimia; congelamento affettivo	
Salovey & Mayer	4 dimensioni intelligenza emotiva	12
Fromm (1973) / Wrangham (2019)	Aggressività benigna vs. maligna	13
Walker (1979)	Ciclo della violenza domestica	13
Bandura (2017)	Meccanismi di disimpegno morale	13
Arendt	Banalità del male	13

Parole chiave della materia

salute · benessere · normalità · disease · illness · sickness · to cure · to care · agentività · stigma · Gehirnpsychiatrie · Geistespsychiatrie · trattamento morale · patoplastica · parzialità della follia · alienazione · comprensibilità · Einfühlung · empatia cognitiva · empatia affettiva · simulazione incarnata · neuroni specchio · Theory of Mind · compassione · bias empatico · sovrattivazione empatica · burnout · paura · ansia · angoscia · freezing · arousal · amigdala · BNST · filiera emotiva · meccanismi di difesa · ritiro primitivo · diniego · proiezione · scissione · identificazione proiettiva · idealizzazione · rimozione · dissociazione · formazione reattiva · spostamento · isolamento affetti · umorismo · angoscia di castrazione · angoscia di frammentazione · angoscia di abbandono · semiologia · segni · sintomi · catatonia · coscienza · orientamento · amnesia · confabulazione · illusione · allucinazione · agnosia · anosognosia · farmacodinamica · antipsicotici · antidepressivi · ansiolitici · stabilizzatori · litio · emozione · umore · eutimia · anedonia · apatia · alfa privativo · pendolo timico · depressione mascherata · bipolare I

· bipolare II · ciclotimico · rimuginio · ruminazione · DAG ·
attacco di panico · nevrosi · egodistonico · egosintonico ·
struttura nevrotica · scompenso · esame di realtà · ossessioni ·
compulsioni · conversione · isteria · DOC · temperamento ·
carattere · personalità · tratto · stato · goodness of fit ·
diatesi · egosintonia · diffusione dell'identità ·
organizzazione borderline · cluster A/B/C · BPD · DBT · Big Five ·
PDM-2 · psicosi · organica · funzionale · io-qui-adesso ·
dissociazione schizofrenica · delirio · autismo schizofrenico ·
depersonalizzazione · derealizzazione · sintomi positivi ·
sintomi negativi · tipo 1 · tipo 2 · delirium tremens · Korsakov ·
epilessia · crisi pantoclastica · Körper · Leib · disforia di
genere · parafilia · bisogno vs. desiderio · snodi di Lalli ·
anoressia nervosa · bulimia nervosa · BED · ortoressia ·
vigoressia · Culture-Bound Syndrome · fattore patoplastico ·
falso sé · dispercezione corporea · alessitimia ·
desomatizzazione · verbalizzazione · transnosografico · TAS-20 ·
intelligenza emotiva · regolazione affettiva · congelamento
affettivo · attaccamento insicuro · rabbia · aggressività ·
violenza · canalizzazione · aggressività maligna a caldo ·
aggressività maligna a freddo · ciclo della violenza · falsa
riappacificazione · ruota del potere · disimpegno morale ·
deumanizzazione · banalità del male · violenza domestica ·
violenza psicologica

Filo conduttore

Si parte chiedendo cosa sia la salute e si scopre subito che non c'è una risposta unica: salute, malattia, normalità e benessere non coincidono (Lez. 01). La storia della psichiatria mostra che il confine tra organico e passionale è sempre stato conteso — e che ogni risposta ha prodotto pratiche di cura diverse (Lez. 02). Per stare davvero accanto a chi soffre servono strumenti: l'empatia nelle sue diverse forme e con i suoi bias (Lez. 03); la capacità di leggere le emozioni e le difese (Lez. 04); una semiologia precisa per osservare comportamento, coscienza, memoria,

percezione (Lez. 05). Con questi strumenti si arriva ai grandi quadri clinici — dalle sindromi affettive e ansiose (Lez. 06) alle nevrosi (esame di realtà mantenuto, Lez. 07), fino ai disturbi di personalità (tratti rigidi ed egosintonici, Lez. 08) e alle psicosi (rottura radicale con la realtà, Lez. 09). La traiettoria è un continuum: non categorie stagno, ma gradi crescenti di compromissione identitaria e relazionale. Il modulo si chiude con quattro lezioni sul corpo: sessuato, deformato, alessitimico, violato. In tutte e quattro il corpo parla di una relazione ferita — con sé stessi, con l'altro, con il proprio mondo interno. Il filo rosso, ribadito da Cargnello fin dall'inizio, è uno solo: la clinica è l'incontro con qualcuno, mai la gestione di qualcosa.

Domande di orientamento allo studio

Qual è il filo conduttore dell'intera materia di Salute Mentale? Il corso costruisce progressivamente gli strumenti per incontrare chi soffre. Si parte dalle definizioni di salute, malattia e normalità (Lez. 01) e dalla storia della psichiatria (Lez. 02). Si acquisiscono strumenti relazionali — empatia (Lez. 03), difese emotive (Lez. 04), semiologia (Lez. 05) — e li si applicano ai grandi quadri clinici (Lez. 06–09) e al corpo come luogo della sofferenza (Lez. 10–13). Il filo rosso: la clinica è incontro, non classificazione. (Lez. 01–13)

Come si collega il dualismo storico *Gehirnpsychiatrie/Geistespsychiatrie* (Lez. 02) con i quadri clinici delle lezioni successive? Le psicosi organiche (Lez. 09) appartengono al filone organicista. Le psicosi funzionali e la schizofrenia richiedono entrambi gli sguardi. Nevrosi (Lez. 07) e disturbi di personalità (Lez. 08) affondano le radici nel paradigma passionalista. Le depressioni oscillano: endogene verso il polo biologico, psicogene verso quello passionale (Lez. 06). I DCA (Lez. 11) confermano il pattern: vulnerabilità biologica + fattori psicologici e sociali, con la cultura come fattore patoplastico. (Lez. 02, 06, 07, 08, 09, 11)

Come si collegano i meccanismi di difesa (Lez. 04) con i tre grandi quadri strutturali — nevrosi, disturbi di personalità, psicosi? I MDD sono il ponte tra la filiera emotiva e la struttura psicopatologica. Difese primitive (scissione, proiezione, identificazione proiettiva) dominano nei disturbi di cluster A e B e nella struttura borderline/psicotica (Lez. 08, 09). Difese mature (rimozione,

formazione reattiva, spostamento) sono caratteristiche della struttura nevrotica (Lez. 07). Il tipo di angoscia orientamento ulteriore: castrazione (nevrosi) · abbandono (borderline) · frammentazione (psicosi). (Lez. 04, 07, 08, 09)

Qual è la differenza tra sintomo egodistonico ed egosintonico, e perché è clinicamente rilevante? Il sintomo egodistonico è vissuto come estraneo: il soggetto ne soffre, lo riconosce come problema, chiede aiuto — caratteristica della nevrosi (Lez. 07). Il sintomo egosintonico è vissuto come parte del sé: il soggetto non lo percepisce come problema, spesso sono gli altri a soffrirne — caratteristica dei disturbi di personalità (Lez. 08). La distinzione è decisiva per la motivazione al trattamento. (Lez. 07, 08)

Come si collega il "fattore patoplastico" della cultura (Lez. 11) con il principio della "patoplastica" di Pinel (Lez. 02)? Pinel sosteneva che la malattia si esprime in modo unico su ogni persona — il substrato è universale, la forma è individuale. Jaspers estende questo principio alla cultura: la cultura non causa la sofferenza, ma ne plasma la forma. Chi è vulnerabile si ammala; la società indica in quale modo. L'anoressia/bulimia come "disturbi etnici" (Devereux) ne è l'esempio più chiaro. (Lez. 02, 11)

Come si collega il corpo alessitimico (Lez. 12) con i DCA (Lez. 11), le dipendenze e l'empatia (Lez. 03)? L'alessitimia — incapacità di nominare le emozioni — si ritrova trasversalmente in molti quadri perché la sofferenza emotiva non verbalizzata cerca altri canali: il cibo, la sostanza, il corpo. Chi non riesce a nominare le proprie emozioni fatica anche a riconoscerle nell'altro (deficit empatico, Lez. 03). Le difese della Lez. 04 come l'isolamento degli affetti diventano strutturali nei soggetti alessitimici. (Lez. 03, 04, 11, 12)

Come si leggono i meccanismi di disimpegno morale (Lez. 13) alla luce dei bias empatici (Lez. 03)? I bias empatici (Pezzoli) mostrano perché sia difficile empatizzare con chi è molto diverso o giudicato colpevole. Il disimpegno morale (Bandura) compie un passo ulteriore: sospende attivamente la risposta morale attraverso la deumanizzazione, la diffusione della responsabilità, l'attribuzione di colpa alla vittima. Entrambi i meccanismi abitano anche gli operatori: la vigilanza su sé stessi è condizione necessaria del lavoro di cura. (Lez. 03, 13)

Come descriveresti l'approccio complessivo del corso alla persona che soffre? Il corso rifiuta la logica della catalogazione: non si tratta di imparare a etichettare i disturbi, ma di sviluppare la capacità di incontrare chi soffre. Questo richiede: capire la storia (Lez. 02); empatia matura con consapevolezza dei suoi limiti (Lez. 03); leggere emozioni e difese (Lez. 04); osservare con rigore semiologico (Lez. 05); conoscere i quadri clinici senza ridurre la persona ad essi (Lez. 06–13). La distinzione tra *to cure* e *to care* — introdotta in Lez. 01 — è la bussola permanente. (Lez. 01–13)